¿Qué es la Tuberculosis (TBC)?

Es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria llamada *Bacilo de Koch*. Afecta principalmente a los pulmones, pero también puede dañar otros órganos como ganglios, cerebro y columna vertebral entre otros.

¿Cómo se transmite la TBC?

Se transmite a través del aire. Cuando una persona enferma de TBC pulmonar al toser, gritar, hablar, estornudar elimina bacilos al ambiente y las personas expuestas toman contacto directo con las gotas respiratorias cargadas de bacilos. Esto es más frecuente cuando el contacto ocurre en personas que comparten más de 30 horas semanales en ambientes cerrados y poco ventilados.

Para que una persona se enferme de TBC es necesaria la infección por el *Bacilo de Koch*, **pero su presencia no es suficiente** para la aparición de la enfermedad. Que la infección devenga en enfermedad depende de que, conjuntamente a la infección por el Bacilo, coexistan en el expuesto algunos determinantes sociales y de salud como pobreza, hacinamiento o enfermedades preexistentes inmunosupresoras

Etapas de la Tuberculosis

Expuesto

Es la persona que ha estado en contacto con una persona enferma de tuberculosis.

Infección tuberculosa o tuberculosis latente

Se produce cuando una personatiene bacterias de TBC en su cuerpo, pero **no presenta signos ni síntomas** de la enfermedad. La prueba de tuberculina (PPD) es positiva, pero las radiografíasde tórax son normales. A estas personas se les prescribe un tratamiento que se conoce como “quimioprofilaxis” o “terapia preventiva” con la finalidad de prevenir la aparición de la enfermedad.

Las personas con TBC latente no tiene capacidad de trasmitir la enfermedad (no contagian) no han desarrollado la enfermedad aun, pero podrían hacerlo en un futuro.

Enfermedad tuberculosa o tuberculosis activa

Se produce cuando una persona presenta síntomas de la enfermedad, la prueba de tuberculina podría ser positiva o negativa y las radiografías de tórax demuestran lesiones compatibles con la enfermedad. Estas personas deben recibir tratamiento curativo (mínimo de 6 meses) y son los únicos con capacidad de transmitir la enfermedad.

¿A qué síntomas hay que prestar atención?



¿Cómo se diagnostica la Tuberculosis?

Los exámenes que se realizan para el diagnóstico de TBC serán indicados según criterio médico, dependiendo de la forma de presentación clínica (según el órgano afectado).

Examen del esputo o baciloscopia

Es la forma más sencilla y rápida de diagnosticar TBC. Consiste en tomar muestras de la expectoración con la finalidad de observar al microscopio óptico los bacilos que producen la enfermedad.

Cultivo de esputo

Es una prueba más sensible. Es de especial utilidad para el diagnóstico en personas cuya baciloscopia resulto negativa, tienen evolución desfavorable o antecedentes de tratamiento.

Radiografiaría de tórax

Es una prueba esencial y de gran utilidad en el diagnóstico de TBC. Valora la extensión de la enfermedad pulmonar, su evolución y sus secuelas.

Prueba cutánea de la tuberculina o PPD

Se aplica mediante el *Método de Mantoux*. Consiste en aplicar debajo de la piel del antebrazo una sustancia llamada "tuberculina" que es un derivado proteico purificado del cultivo del *Mycobacterium tuberculosis*. Los resultados se evalúan dos días más tarde en milímetros.

¿Quiénes se pueden enfermar de Tuberculosis?

Cualquier persona puede adquirir esta enfermedad. Sin embargo, algunas tienen un riesgo incrementado de infección y luego de evolucionar a la enfermedad.

Entre las personas con alto riesgo de enfermarse con TBC se incluyen las siguientes:

- *Convivientes de más de 30 horas semanales*
- *Trabajadores de la salud, de geriátricos, en contexto de encierro*
- *Personas con un estado de nutrición e inmunidad deficientes o que padecen de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, VIH y SIDA, entre otras.*
- *Personas que viven en estado de hacinamiento y en condiciones precarias.*
- *Personas con un consumo problemático de sustancias*
- *Personas privadas de la libertad, recluidas en cárceles*

¿Cómo se previene la Tuberculosis?

La medida de prevención más efectiva es evitar el contagio, por lo que es sumamentenecesario el diagnostico e inicio de tratamiento precoz en toda persona con síntomas respiratorios compatible con TBC. Es importante incentivarlas y apoyarlas a que cumplan y terminen el tratamiento correctamente para que puedan curarse y de esta manera cortar la cadena de transmisión.

Realizar el control médico de los contactos convivientes para detectar posibles nuevos casos y realizar tratamiento preventivo en aquellos que lo requieran.

Otras medidas de prevención generales son:

- *Ventilar diariamente todos los ambientes abriendo puertas y ventanas, dejando que entre la luz natural (el bacilo de Koch no resiste la luz solar mucho tiempo); Cubrirse la boca con el antebrazo al toser.; Lavado frecuente de manos; Mantener una alimentación adecuada y variada.*
- *En menores de 5 años para prevenir las formas graves de TB se debe aplicar antes de salir de la maternidad la* ***vacuna BCG en recién nacidos (incluida en el Calendario Nacional de Vacunación)***
- *Promover en nuestro lugar de trabajo el acceso a información, capacitación y/o educación sobre aspectos básicos y fundamentales relacionados con la TBC.*

Ante la presencia de síntomas consultar al centro de salud más cercano para un diagnóstico adecuado e inicio de tratamiento en caso de ser necesario.

¿Qué hacer cuando hay un caso de TBC en la escuela?

- Asegurarse que sea un caso real de TBC, solicitando la información correspondiente.
- No alarmarse y consultar con la autoridad competente (Programa regional de Control de la TBC).
- El Programa regional de Control de TBC será responsable de determinar las acciones a seguir con respecto al caso de TBC.
- Verificar que brinden apoyo y tratamiento al niño y su familia.

¿Qué acciones implementará el Centro de Salud u Hospital activado por el Municipio?

Desarrollará un control de foco, esto es:

- Registro de todos sus contactos.

  Es decir, aquellos que comparten espacios con el niño infectado.
- Examen Clínico.
- Prueba de Sensibilidad Tuberculínica.
- Examen Radiológico de Tórax.
- Examen Bacteriológico.

Recomendaciones de Control de Foco para Equipos de Salud (link)

En la situación especial de las escuelas para categorizar el riesgo se deberá tener en cuenta:

Si el caso índice es un profesor, educador o auxiliar docente, se debe tener en cuenta que:

- Los contactos de niños con un profesor con TB durante seis o más horas por día de clase, seconsideran dentro del grupo de contactos íntimos.
- En general, los contactos entre profesores son esporádicos u ocasionales.

Si el caso índice es un alumno:

- Si presenta *BK positiva*, se estudiarán los contactos por orden de prioridades: 1º los íntimos, 2º los frecuentes y, en base a los resultados de esos estudios, se decidirá si se estudian o no los contactos ocasionales.
- Si presenta *BK negativa*, se estudiarán sólo los contactos íntimos. Si entre ellos hay un alto porcentaje de infectados y/o algún enfermo, se estudiarán el resto de los contactos.